



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رابعياً : عايده خلف الله صالح
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : الهرم
رقم البطاقة : 24712092100121 رقم التليفون : 01018342543
العمر (تاريخ الميلاد) : 09-12-1947 المهنة : ربه منزل
العنوان : فيصل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 29-09-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (.....)
المقر بما فيه
التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مريد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/رمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / د. / د. / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص



جمهورية مصر العربية
مجلس الوزراء

الوزير

خلف الله صالح احمد جبريل

أمانة مركز متابعة في المكتب الفني
القاهرة - الجيزة

٢٤٧ ١٣٠٩ ٢١٠٠١ ٢١

J0369913



٢٠٢١/٧٩ ٢٤٧١٣٠٩٢١٠٠١٢١

مجلس التعليم

مركزية

الهيئة المصرية حتى ٢٠٢١/٧٩



Name: عائدة حلف صالح وفده		
MR. : 4911		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحت طية وبعد،،		
إسماء للطلب المقدم عن بشأن تقرير طبي للمريض		
رقم طبي:		بقسم:
يشترك بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها		
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :
وبعد الكشف والفحوصات والمباينة وجد أنها		
The patient is a 77-year-old individual with a history of post-menopausal right breast cancer staged cT3 N2 M0 by computed tomography and bone scan. Pathology demonstrated estrogen receptor (ER) and progesterone receptor (PR) positivity (8/8) and HER2 negativity. The patient received neoadjuvant aromatase inhibitor therapy (Femara) from January 2025 through June 2025, followed by right modified radical mastectomy in August 2025 with postoperative radiation therapy (PORT). Ongoing adjuvant endocrine therapy with letrozole and bone-protective therapy with zoledronic acid (Zometa) have been prescribed, and relevant laboratory studies have been performed and reviewed. The current treatment plan includes continuation of letrozole 2.5 mg daily and zoledronic acid (Zometa) administered every two months as ordered by pharmacy. No additional cycles or weeks of therapy are specified in the notes.		
تحريرا في ,		
التاريخ :		19-09-2026
الوقت :		سريفة الشاوي
الطبيب المعالج :		
بعيند ,		

Patient Name : (الأستاذة / عايدة خلف الله صليح)	Request No. : 13002290
Patient No. : 24712092100121	Request Date : 14/08/2025
Path No. : 2536/25	Verification Date : 18/08/2025
Sex : Female	Financial Category : جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age : 78 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

- Histologic response to therapy: Pathologic partial response to therapy.

Diagnosis:

Right breast cancer (Post-NAT), Right modified radical mastectomy:
Residual viable invasive duct carcinoma, Grade 2 (Cellularity 70%) (Actual tumor size 2.1x1.5 cm).

- DCIS: Absent.
- Nipple and areola: Free.
- Deep margin: Free.
- Axillary lymph nodes: Positive viable metastatic deposits in two out of twelve lymph nodes (2/12) (The largest nodal mets 2.8 cm with extra-nodal extension).
- Stage: ypT2, ypN1a.
- RCB: 4.086, RCB class-III.

Signature

Dr. Walea Ibrahim Ghoneim,
Dr. Duaa Mohamed,

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 28/08/2025 11:16:04

Page 1 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - نيل كورالiche - ميسر El Qadima - Cairo, Egypt
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Coraliche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name	: الأستاذة / عيادة خلف الله صديق	Request No.	: 13009886
Patient No.	: 24/12092100121	Request Date	: 12/09/2024
Path No.	: 3443/24	Verification Date	: 07/10/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبلترة
Age	: 76 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc. :		IHC No.	:
		Registered by	: marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Right breast 11 O'clock mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 12/09/2024.

Technique:

- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:

- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8 /8).
- PR: Strong nuclear reaction in 80 % of tumor cells (score 8 /8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67: 35% nuclear reaction of tumor cells.

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II.

IPT:

- ER: Positive (score 8 /8).
- PR: Positive (score 8 /8).
- Her2: (score 1+).
- Ki67: Positive in 35% of tumor cells.

Comment: The cancer in this sample has a low level (1-10%) of ER expression by IHC. There are limited data on the overall benefit of endocrine therapies for patients with these results, but they currently

Verified by :



Patient Name الأستاذ / عابد خلف الله - صالح
Patient No. 24712092100121
Path No. 3443/24
Sex Female
Age 76 Y
Referring Doc:

Request No. 13009886
Request Date 12/09/2024
Verification Date 07/10/2024
Financial Category برنامج دار السلام - ميثاق
Department Out Patient

Registered by marwa mohamed youssa

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

suggest possible benefit, so patients are considered eligible for endocrine treatment. There are data that suggest invasive cancers with these results are heterogenous in both bc. ev. r and biology and often have gene expression profiles more similar to ER-negative cancers.

* Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations. proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her 2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr. Aml Hareedy,
Dr. Haba Hassan

Verified by .



Patient Name: Aya Kh. A. H. S. 123456789	Date: 05/11/2024
Exam: CT ABDOMEN & PELVIS WITH	Age: 77 Years
CONTRAST	
Medical ID: 123456789	Patient ID: 03207

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:

- Right breast UOQ irregular mass measuring 2.7 X 2.3 cm.
- Right axillary level I and II pathological lymph nodes the largest is measuring 2.9 X 5.2 cm.
- Few bilateral pulmonary reaching 2-3 mm.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Heterogenous texture of the thyroid gland

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No definite enhancing focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes. Right renal cortical cyst.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Satisfactory filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.



Patient Name	Amr El Aidi	Age	77	Sex	Male	Date	05/11/2024
Ref. C.I. AB	00000000000000000000	Ref. C.I. VS	00000000000000000000	Age	77	Year	6
CONTRAST							
Medical ID	00000000000000000000					Patient ID	00000000000000000000

Scanned skeleton: left iliac wing sclerotic patch,

right femoral head, right pubic and left ischial sclerotic foci mostly bone islands.

Opinion:

- **Reported case of breast cancer,**
- **Bilateral pulmonary nodules for follow up**
- **Few osseous lesions for bone scan.**

Dr. mohamed Mohsen, M.D.



NAME: AIDA KHALFALLAH SALEH
EXAM: BILATERAL SONO- MAMMOGRAPHY

ID:
DATE: 11/9/2024

MAMMOGRAPHY REPORT

Bilateral Soft Tissue Mammography with Complementary Ultrasound Revealed

Clinical background: Right breast lump 3 months ago

Findings:

- Fatty breast parenchyma (ACR a).
- Right breast upper central irregular speculated mass of high density, nipple retraction and diffuse skin thickening as well segmental pleomorphic microcalcifications.
- Left UOQ isodense nodule by US left breast UOQ 2 o'clock oval, hypoechoic, avascular nodule measures 6 x 6 mm.
- U/S showed right upper central irregular spiculated hypoechoic vascular mass lesion measures 25 x 37 mm with anterior ductal extension reaching nipple.
- No cystic lesions.
- No evidence of duct ectasia.
- Normal left skin thickness and contour.
- Left nonspecific axillary lymph nodes of preserved fatty hilae.
- Right axillary level I, II & III pathological lymph nodes the largest at level I are amalgamated measuring 30 x 40 mm.

CONCLUSION:

- **Right breast locally advanced malignant looking mass lesion and ipsilateral axillary pathological lymph nodes, BIRADS 5. For biopsy.**
- **Left breast UOQ nodule of indeterminate nature (BIRADS 3).**

Best Regards,
Dr. Wafaa Helder, MSc

MDT FORM - 1/2029 G

Name	عائدة خلف المصباح	MRN	٢٤٤
Age	76 y.	ID	C. C.
Menopausal status	post-M.	Phone	01018342343
NRS SCORE		Marital status	M.
BMI		Family history	irrelevant
CO morbidity	Diabetic, Hypertensive	REASON OF MDT	post-op

Clinical Data

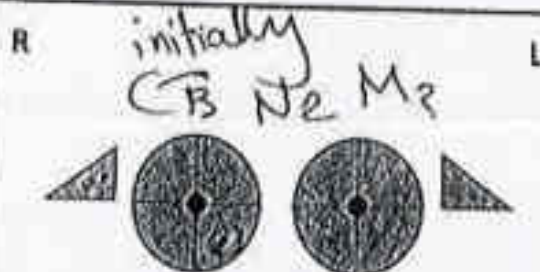
BX:	I.D.C GII		
ER:	PR:	HER 2:	KI67:
8/8	8/8	-ve	30%.

Sonomammography:

post MAMM MRI

Mets Workup:

residual viable mucous duct carcinoma GII TNM
(cellularity 70%) actual tumor size 2.1 x 1.5
DCIS absent



Recommendations:

nipple and areola -> free
deep margin -> free.

Ns 2/12

stage ypT2, ypN1a

MDT OUTCOME & PLAN

- ① PORT
- ② Adjuvant AI x 4 yrs.
- ③ Zometa / 6 hrs.

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
<i>[Signature]</i>	Dr. Mostafa 2/19/2024	<i>[Signature]</i>			

Patient's Name: Aida Khalaf Allah Saleh
Date: 2025-08-01
Referred by: Prof Dr. no doctor
Hospital: Gonstave Roussey International Egypt

Left Digital soft tissue mammography with high resolution sonography revealed:

Clinical summary: Status post right MRM

Left breast.

- Scattered fibro-glandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/hipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Right mastectomy bed.

- Clear mastectomy bed with thick walled cystic lesion noted underneath the posterior third of the operative bed measuring 4.8 x 12 mm
- Clear right axilla. No pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.

Conclusion:-

- **Left breast (BIRADS 1): normal study.**
- **Clear right mastectomy bed with post surgical organized seroma**

dr farah elshobaky

Patient's Name:

Aida Khalaf Allah Saleh

Date:

2026-08-01

Referred by:

Prof. Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

Left Digital soft tissue mammography with high resolution sonography revealed:

Clinical summary: Status post right MRM

Left breast.

- Scattered fibro-glandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/ nipple/ areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Right mastectomy bed.

- Clear mastectomy bed with thick walled cystic lesion noted underneath the posterior third of the operative bed measuring 4.8 x 12 mm.
- Clear right axilla. No pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.

Conclusion:

- **Left breast (BIRADS 1): normal study.**
- **Clear right mastectomy bed with post surgical organised seroma**

Patient's Name: Aeda kalfalla saleh
Date: 2026-08-1
Referred by: Prof Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Pelvi-abdominal ultrasonographic examination, revealed:

- The liver is not enlarged measuring about 14 cm with homogeneous echo-pattern. No definite focal lesions or IHRD by US criteria.
- Patent portal vein with average diameter showing normal flow direction.
- Gall bladder is surgically removed. Non-dilated CBD.
- Spleen is not enlarged measuring about 12 cm with homogenous echo pattern and no definite focal lesions.
- The midline structures and visualized portions of the pancreatic head are free.
- Colonic gaseous distension.
- Both kidneys are average in size, shape, echo-pattern and differentiation. No backpressure changes.
- No ascites at time of examination.
- Average filling of the urinary bladder with no stones or masses.
- Normal size of the uterus with no definitive focal lesion.
- No gross adnexal lesion.
- No pelvic fluid collection.

Conclusion:

- Colonic gaseous distension.
- Otherwise, unremarkable study.

Best regards;
Dr. Mohammad Islam

جمهورية مصر العربية
وزارة الداخلية
ملاحة بحرية

عائده
كاتب المصالح احمد جبريل
عربة جبريل شهابية بن الملك فيصل
الهدم - الخمر

٢٠١٢ - ٠٩ - ٢١ ٢٤٧١٢٠٩٢١٠٠١٢١

J03349913



٢٠٢١/١٢ ٢٤٧١٢٠٩٢١٠٠١٢١

بجون عل

النسب سائلة

شعاع احمد صالح احمد

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/١٢/١٥

١

ECHO REPORT

Name: عايمة خلف

Date: 21 / 7 / 2025

EF	65%	55-75%	PWT	0.8	0.6-1.1cm
LVEDD	4.9	3.5-5.8cm	AO.R	2.5	2-3.7cm
LVESD		2-4cm	LA	3.7	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	1.0	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

requent premature beats

LV dimensions ——— normal

LV wall thickness ——— normal

LV diastolic function DD grade II

SWMA ——— normal. However IHD cannot be excluded

LA and Ao root dimensions ——— normal

Mitral Valve T1 L1 R1

Aortic valve Sclerotic P.D with no significant systolic gradient

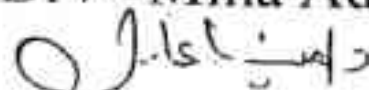
Tricuspid valve T1 L1 R1

Pulmonary valve ——— normal

Right side and systolic function ——— normal

Intracardiac masses and effusion ——— normal

Dr / Mina Adel



Patient No. : 3449-2024
Patient Name : الأستاذة / عائدة خلف الله صالح
Sex : Female Age: 76 Y
Financial Cate : جوسف روسي - ميلدرة
Department : Out Patient
Referring Doc :

Request No : 13005740
Request Date : 14-07-2025 13:15
Verification Date : 14-07-2025 14:17
Sample Type : Serum
Test Status : Routine
Analyzers : biolis_hermel

Clinical Chemistry Report

Test	Result	Unit	Ref. Range	
ALT (SGPT)	12.3	U/l	Up to 31.0	)
AST (SGOT)	18.9	U/l	Up to 31.0	)
Serum Creatinine	1.1	mg/dl	0.6 - 1.2	)
Serum Sodium (Na)	140.0	mmol /l	136.0 - 148.0	)
Serum Potassium (K)	3.9	mmol/l	3.5 - 5.2	)
Urea	50.8	mg/dl	17.0 - 43.0	)

Signature

Dr./Manal Mokhtar

Patient No. : 3449-2024
Patient Name : الأستاذة / عايدة خلف الله صالح
Sex : Female Age: 76 Y
Financial Cate : جوستاف روسي - عيادته
Department : Out Patient
Referring Doc :

Request No : 13005740
Request Date : 14-07-2025 13:15
Verification Date : 14-07-2025 14:51
Sample Type : Serum
Test Status : Routine
Analyzers :

Virology Report

Test	Result	Ref. Range
HBs Ag	NEGATIVE	Negative 0 - 1 Positive greater than 1
HCV_Ab	NEGATIVE	Negative 0 - 1 Positive greater than 1
HIV Ab	NEGATIVE	

Signature

Dr.Asmaa Hamed

Patient Name : عبده خلف الله صالح
Patient No : 3449-2024
Sex : Female Age : 76 Y
Financial Cate : جوستاف روسي - مبانزه
Department : Out Patient
Referring Doc :
Lab No. : 13005740
Request Date : 14-07-2025 13:15
Verification Date : 14-07-2025 13:45
Sample Type : EDTA Blood
Test Status : Routine
Analyzers : DXH_600_Hermel

Complete Blood Picture

Test	Result	Unit	Ref. Range
Hemoglobin	12.1	g/dL	12.0 - 16.0
RBCs	4.3	10 ⁶ /uL	4.0 - 6.5
Haematocrit (PCV)	35.0	%	36.0 - 50.0
MCV	82.4	fL	76.0 - 101.0
MCH	28.4	pg	26.0 - 32.0
MCHC	34.5	g/dL	31.5 - 34.5
RDW-CV	13.7	%	11.6 - 14.0
PLT	244	10 ³ /ul	150 - 450
WBCs.Total	8.1	10 ³ /uL	4.0 - 11.5

Differential Leucocytic Count :

	Relative		Absolute		
Neutrophils%	58.8	%	4.76	/cmm	2.00 - 7.00
Lymphocytes%	29.9	%	2.42	/cmm	1.50 - 3.50
Monocytes %	8.6	%	0.70	/cmm	0.20 - 1.00
Eosinophils %	2.4	%	0.19	/cmm	Up to 0.50
Basophils %	0.3	%	0.02	/cmm	Up to 0.10

Signature

Dr./Manal Mukhtar

Patient No. : 3449-2024	Request No. : 13005740
Patient Name : الأستاذ / عابد خلف الله صالح	Request Date : 14-07-2025 13:15
Sex : Female Age: 76 Y	Verification Date : 14-07-2025 14:01
Financial Cate: جوسفاروسي - مبادرة	Sample Type : Citrated Plasma
Department : Out Patient	Test Status : Routine
Referring Doc :	Analyzers : CA600_HERMEL

Coagulation Profile Report

Test	Result	Unit	Ref. Range
PT			
Prothrombin Time	11.7	sec	
Control	11.2	sec	
Activity	92.9	%	
INR	1.04		Therapeutic range 2-4

Signature

Dr./Manal Mokhtar

Patient Name: Aida Khalaf Allah Saleh Ahmed	Date : 21/07/2025
Exam : C.T CHEST	Age : 77 Year(s)
Medical ID: 3449/2024	Pat. ID: 93907

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

Compared to the last study 5-11-2024

- Right breast UOQ irregular mass measuring 2.7 X 2.3 cm.
- Right axillary level I and II pathological lymph nodes the largest is measuring 2.9 X 5.2 cm.
- Few bilateral pulmonary reaching 2-3 mm.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Heterogenous texture of the thyroid gland.



Opinion:

Reported case of breast cancer.

- Near stationary course since the last study.

Dr. AYA GABR

KHALAF, AYDAA Patient ID: 10110225003523 DOB: 09-Dec-1947 Date: 23-Feb-2025

Patient Lastname: Khalaf

Patient Firstname: Aydaa

HIS Patient ID: 10110225003523

RIS Patient ID: 366318

Date of Birth: 09/12/1947

Procedure: 70030, Bone Scan

Medical Question:

Clinical Comment:

===== REPORT TEXT =====

99mTc MDP Bone Scan Report (23/02/2025)

• Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of 99mTc MDP Revealed:

" Warm tracer uptake is noted at mid left femoral shaft extending to distal shaft likely postoperative bone remodeling for further clinical correlation.

" No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.

" Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.

" Advanced both shoulders osteoarthritic changes.

" Arthritic changes are noted over both knee joints.

" Both kidneys are visualized.

Conclusion:

" No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Much Obligated

Dr. Mayar Mattar, MSc

===== REPORT TEXT ENDE =====

NAME: AIDA KHALFALLAH SALEH
EXAM: BILATERAL SONO- MAMMOGRAPHY

ID: 1
DATE: 11/9/2024

MAMMOGRAPHY REPORT

Bilateral Soft Tissue Mammography with Complementary Ultrasound Revealed

Clinical background: Right breast lump 3 months ago

Findings:

- Fatty breast parenchyma (ACR a).
- Right breast upper central irregular speculated mass of high density, nipple retraction and diffuse skin thickening as well segmental pleomorphic microcalcifications.
- Left UOQ isodense nodule by US left breast UOQ 2 o'clock oval, hypoechoic, avascular nodule measures 6 x 6 mm.
- U/S showed right upper central irregular spiculated hypoechoic vascular mass lesion measures 25 x 37 mm with anterior ductal extension reaching nipple.
- No cystic lesions.
- No evidence of duct ectasia.
- Normal left skin thickness and contour
- Left nonspecific axillary lymph nodes of preserved fatty hilae.
- Right axillary level I, II & III pathological lymph nodes the largest at level I are amalgamated measuring 30 x 40 mm.

CONCLUSION:

- Right breast locally advanced malignant looking mass lesion and ipsilateral axillary pathological lymph nodes, BIRADS 5. For biopsy.
- Left breast UOQ nodule of indeterminate nature (BIRADS3).

Best Regards,
Dr. Wafaa Heidar, MSc



Patient Name	: الأستاذة / عائدة خلف الله صليح	Request No.	: 13009886
Patient No.	: 24712092100121	Request Date	: 12/09/2024
Path No.	: 3443/24	Verification Date	: 07/10/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مياثره
Age	: 76 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc. :		IHC No.	:
		Registered by	: marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Right breast 11 O'clock mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 12/09/2024.

Technique:

- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:

- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8 /8).
- PR: Strong nuclear reaction in 80 % of tumor cells (score 8 /8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67: 35% nuclear reaction of tumor cells.

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:

Invasive duct carcinoma, Grade II.

IPT:

- ER: Positive (score 8 /8).
- PR: Positive (score 8 /8).
- Her2: (score 1+).
- Ki67: Positive in 35% of tumor cells.

Comment: The cancer in this sample has a low level (1-10%) of ER expression by IHC. There are limited data on the overall benefit of endocrine therapies for patients with these results, but they currently

Verified by :



Patient Name : الأستاذة / عائدة خلف الله صليح
Patient No. : 24712092100121
Path No. : 3443/24
Sex : Female
Age : 76 Y
Referring Doc :

Request No. : 13009886
Request Date : 12/09/2024
Verification Date : 22/09/2024
Financial Category : اورام دار السلام - مبعرة
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast 11 O'clock mass.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 12/09/2024.

Gross Examination:

- Multiple grayish white tissue cores up to 1 cm long, totally submitted.

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+2) Grade II.
- * Ductal carcinoma in situ: Not detected.
- * Perineural invasion: Not detected.
- * Angioinvasion: Not detected.

Diagnosis:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II.
For further IHC (ER, PR, Her2, Ki67).

Signature
Prof. Dr. Amr Hareedy.
Dr. Heba Hassen.

Verified by :

Patient Name: Aida Khalaf Allah Saleh Ahmed	Date : 05/11/2024
Exam : C.T. ABDOMEN & PELVIS WITH CONTRAST	Age : 77 Year(s)
Medical ID: 349/2024	Pat. ID: 93907

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

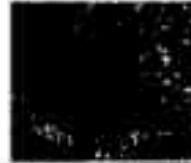
Findings:

I Chest:-

- Right breast UOQ irregular mass measuring 2.7 X 2.3 cm.
- Right axillary level I and II pathological lymph nodes the largest is measuring 2.9 X 5.2 cm.
- Few bilateral pulmonary reaching 2-3 mm.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Heterogenous texture of the thyroid gland.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No definite enhancing focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes. Right renal cortical cyst.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.



Patient Name: Aida Khalaf Allah Saleh Ahmed	Date : 05/11/2024
Exam : C.T. ABDOMEN & PELVIS WITH CONTRAST	Age : 77 Year(s)
Medical ID: 349/2024	Pat. ID: 93907

***Scanned skeleton:** left iliac wing sclerotic patch.

Right femoral head, right pubic and left ischial sclerotic foci mostly bone islands.

Opinion:

- **Reported case of breast cancer.**
- **Bilateral pulmonary nodules for follow up**
- **Few osseous lesions for bone scan.**

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الاستراتيجية
صحة
مصر

MDT FORM

9/12/2024 G

Name	كايدة حليم الله	MRN	
Age	72	ID	٣٤٤٩/٠.٠٤
Menopausal status	postmenop	Phone	0618342543
NRS SCORE		Marital status	married
BMI		Family history	+ve
CO morbidity	HTN, DM	REASON OF MDT	new malignant

Clinical Data

BX: invasive duct carcinoma	R	L
ER: +ve 8/8	PR: +ve 8/8	HER2: -ve 35%
Sonomammography: Rt Breast locally advanced lesion - pathologist		
Mets Workup: Lymph Nodes	TNM	
Mets workup -> few Pulmonary Nodules few osseous Bone Lesion	Bone Scan Requested	

Recommendations:

MDT OUTCOME & PLAN

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : عابد خلف الله صالح العبد

Sex:

3- Medical number:

Female

83336283

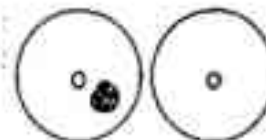
Old Med :

LMD PWD

3449-2024

2-ID number:

Patient Age : 77 Y



Family history

Family history

+ve

Phone

Phone

01018342543

BMI

BMI

32

REASON OF MDT

REASON OF NOT

MDT

marital status

Marital Status

MARRIED

NRS Score

NRS Score

2

GROUP

GROUP

C

Date of MDT

Date Of MDT

09/12/2024 ☐

Co morbidity

Co morbidity

dm,hln

CHOLE

CYSTECTOMY

FRACTURE LT

FEMUR

Menopausal

status

Menopausal Status

POSTMENOPAUSAL

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

rt breast locally advanced lesion

Mets Workup :

few pulmonary nodules

few osseous bone lesion

BX

IDC

BX COMMENT:

ER

8/8

ER COMMENT:

PR

8/8

PR COMMENT:

Her 2 Neu

Her 2 Neu

Her 2 Neu COMMENT:

-ve

SISH

SISH

SISH COMMENT:

Ki67

35

T

CT3

N

2

M

?

Sonomammography

PATIENT HISTORY

BONE SCAN

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

START NEOADJUVANT AROMATASE INHIBITOR TULL RESULT OF BONE SCAN THEN REMDT

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

MEDICAL ONCOLOGY

Date: 10/12/24

RADIOLOGY

RADIOLOGY

Date: 10/12/24

SURGERY

SURGERY

Date: 10/12/24

PATHOLOGY

PATHOLOGY

Date: 10/12/24

Psychiatric

Psychiatric

Date: 10/12/24

Nutrition

Nutrition

Date: 10/12/24

Patient Name الأستاذ / عابد خلف الله صبح
Patient No. 24712092100121
Path No 3443/24
Sex Female
Age 76 Y
Referring Doc.

Request No. 13009886
Request Date 12/09/2024
Verification Date 07/10/2024
Financial Category لورام دار السلام - صابرة
Department Out Patient

Registered by marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

suggest possible benefit, so patients are considered eligible for endocrine treatment. There are data that suggest invasive cancers with these results are heterogenous in both behavior and biology and they have gene expression profiles more similar to ER-negative cancers.

* Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature

Prof. Dr. Aml Hareedy,
Dr. Heba Hassan.

Verified by :

Printing Date : 07/10/2024 12:00:44

Page 2 of 2

Printed By : marwa mohamed yousse

اسم المريض ثلاثي:

رقم الملف:

صحيفة دخول وخروج

تاريخ الميلاد: ٩/١٢/١٩٤٧ النوع: الجنس:			
الحالة الاجتماعية: الديانة:		المهنة:	
عنوان المريض: رقم التليفون:		الجهة المعلن عنها:	
اسم من يمكن الرجوع اليه: العلاقة:		عنوانه: رقم التليفون:	
حول من قبل: المستشفى العامة: ☐ أخرى: ☐		حدث في: ☐ المنزل ☐ العمل ☐ الطريق ☐	
الطبيب المعالج/الأمر بالدخول: التشخيص النهائي:		قسم الدخول: الدرجة:	
تاريخ الدخول: ١٢/١١/٢٠٢٠		تاريخ الخروج: مدة الإقامة: يوم	
اعتماد الدخول: المعرزة:		كتب الدخول:	

FINAL DIAGNOSIS

التشخيص النهائي

ICD
CODE

ASSOCIATED DIAGNOSIS

التشخيصات المصاحبة

OPERATIONS OR PROCEDURES

العمليات

Autopsy

☐ Yes ☐ No

الحالة عند الخروج

☐ شفاء ☐ تحسن ☐ لم يتحسن ☐ وفاة

خروج إلى:

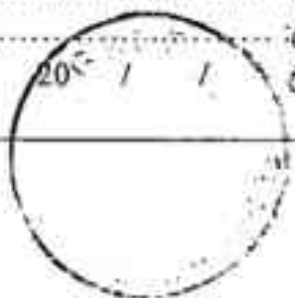
☐ منزل ☐ خروج حسب الطلب ☐ مستشفى أخرى ☐ عامة

اعتماد الخروج

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:



أقرار بالموافقة على دخول المستشفى وتلقي العلاج

أقر أنا الموقع النفاة بصفتي (صلة القرابة للمريض) (.....)

ممتلكات المريض الضعيفة :

- عدم احتضار أموال أو الممتلكات الثمينة إلى المستشفى (مثل التليفون المحمول و المجوهرات ... الخ) و لكن إذا كان لا مفر من ذلك فيوجب عليهم التصهم التام من أن ممتلكاتهم الثمينة موزن عليها تأميناً كاملاً يبدأها لدى خزينة الأمن ، لأن تقبيل المستشفى أنه مسئولية مهما كانت عن فقد تلك الممتلكات الثمينة أو المئاع الشخصي الذي يحضره المريض معهم إلى المستشفى مهما كان السبب سواء نتج عن إهمال أو عدم امتعة.
- الموقع أثناء يشهد بقه ولهم هذا النموذج تماماً و أنه أي المريض أو وكيل عنه سوف يقوم بتنفيذ التعليمات المبونة أعلاه و أنه يوافق عليها .

واجبات المريض

- 1- احترام حق المريض ونوويه علي النحو المحدد في القوانين واللوائح ولائحه اداب المهن بملفقات الرعاية الصحية
- 2- احترام حق المريض ونوويه في الحصول علي الرعاية التي تقدمها المستشفى .
- 3- احترام حق المريض ونوويه في معرفة اسم عضو الطقم الطبي المعالج و/او المشرف و/او المسئول .
- 4- احترام حق المريض ونوويه في الرعاية التي تحترم قيم ومعتقدات المريض الشخصية
- 5- احترام حق المريض ونوويه في معرفة القرارات المتخذة بعينهم والمشاركة في اتخاذها .
- 6- احترام حق المريض ونوويه في رفض الرعاية ووقف العلاج .
- 7- احترام حق المريض ونوويه في الامن والخصوصية والسرية والكرامة
- 8- احترام حق المريض ونوويه في تقديم وعلاج الام .
- 9- احترام حق المريض ونوويه في تقديم شكوي او اقتراح دون الخوف من الانتقام بشأن الرعاية والخدمات .
- 10- احترام حق المريض ونوويه في معرفة سعر الخدمات والاجراءات .
- 11- احترام حق المريض ونوويه في التماس الحصول علي رأي ثاني سواء من داخل المستشفى او خارجها .

- 1- اتباع سياسات واجراءات المستشفى.
- 2- اعطاء معلومات صحيحة وكاملة عن بولنت المريض و التثريخ المرضي للمريض.
- 3- عدم اصطحاب الأطفال أثناء الزيارة.
- 4- عدم احضار اطعمه من الخارج.
- 5- الالتزام بمواعيد الزيارة المحدده بهذا القصى للأفراد عدد 4 افراد و اتباع الاوامر الطبيه في منع الزياره عن الحالات الحرجه
- 6- اتباع سياسة المستشفى لوجود مرافق.
- 7- الحفاظ على مياقي و منتكثات المستشفى.
- 8- عدم التدخين داخل المستشفى
- 9- الالتزام بالملي " سداد المستحقات الماليه " ان وجد طبقا للقانون و اللوائح و سياسة المستشفى للحالات الإحتسافي
- 10- ابداء الاحترام للمرضى الآخرين و العاملين المختصين بشرعية الصحة.
- 11- اتباع خطة العلاج المقترحة.
- 12- ممنوع احضار اي نوع من الغلايات .
- 13- عدم فتح الشبكيه الخاصة بغرفة .

توقيع الموظف المسئول:

توقيع الموظف المسئول:

توفيق الملقم الرقم القومى ٨٨٦٥ - ٥١ - ٨٩ الصف ١٨٧ ٢٠٢٠

كود المتخل	كود المراجع	كود الطبيب
٢٦٤٧٣	١١٧١٣	٢٢٧١٤

توصية المجلس الطبي المتخصص

رقم ٣٦٢٢٠٣٧٢ لسنة ٢٠٢٥
الرقم القومى ٢٤٧١٢٠٩٢١٠٠١٢١

الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة

- بعد الاطلاع علي تقرير الكشف الطبي والابحاث الخاصه بالمواطن المذكور ادناه
- ووفقا لما جاء بقرار وزير الصحة رقم ٤٠٨ لسنة ٢٠٠٩
- وعلي توصية المجلس الطبي المتخصص رقم ٣٥٩٩٣٣٢٢ لسنة ٢٠٢٥/٠٧/١٧
- وعلي تقرير اللجنة الثلاثية المسجل على النظام بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢٩
- اوصي المجلس الطبي المتخصص بجلسة ٢٠٢٥/٠٨/٠٦

بالموافقة علي استكمال علاج المواطن / عايده خلف الله صالح من سرطان بالثدي (مبادرة)
الصادر في شأنه التوصية رقم ٣٥٩٩٣٣٢٢ بمستشفى جوستاف روسي انترناشيونال - مصر
(EPE) بقسم الاورام لمدة ٧ يوم خارجي واذ اخلي تدخل جراحي لاستئصال نحفطي وتكميلي
ورفع للثدي + استئصال الغدد الليمفاوية و/او الغدد الحارسية (كود ١٣١٥٦)
وفقا لما جاء باسعار بروتوكولات العلاج علي نفقة الدولة وطبقا لكود الحالة المرضية

تحريرا في ٢٠٢٥/٠٨/٠٦



تعتبر التوصية نافذه من تاريخ تحرير اللجنة الثلاثية

لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض ومناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف
قيمة القرار مخصصة للعلاج ولا يجوز المطالبة بأي نفقات أخرى سواء للإنتقال أو أي إجراء خارج منطوق القرار

مدير عام

مراجعة طبية

مراجعة ادارية

الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة

د/ وسم محمود عبدالمعيز

حنان اسماعيل ..

د/ محمد عفا

جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE)

طبع في : ٢٠٢٥/٠٨/١٢ ٦١٨٩٥٠٥٣



إذن دخول

اسم المريض : عبدالله بن علي

الرقم الطبي : ٢٤٤٩
٢٠ ٢٤

العنوان :

التشخيص : نزول حاد في الضغط

الإجراء المطلوب : RT MR

الطبيب المعالج : د. هادي

توقيع الطبيب

د. هادي

MDT FORM

24 6 / 20

G

Name	كريمة عبد الحليم	MRN	٣٤٤٩ / ٠. ٢٤
Age	٧٧٤.	ID	٢٩٧١٢٠٩٢١٠١٢١
Menopausal status	post	Phone	٠١ ١٢٤٤٢٠٤٢
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	
CO morbidity		REASON OF MDT	Post M A CT

MDT

Clinical Data

BX:	10 CT	R	L
ER:	PR:	HER 2:	KI67:
8/8	8/8	-	30%
Sonomammography:		post R Breast	
		CT3, N2, M0 CT 4 BS: fu	
Mets Workup:		TNM	
IOCT		Ne. CT char	
Recei. femur f 1/2025		Regist	
till now			

Recommendations:	o/c. LIQ men 3x4 Nraally LN 3x3 mbls for MDT for surgical consult
------------------	---

MDT OUTCOME & PLAN	for R+ MRM following Bone scan Review → free
--------------------	--

SIGNATURE

ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحليل الشخصية

عائده
 خلف الله صالح احمد جبريل
 ١ عزبة جبريل شهبية بن الملك فيصل
 الهرم - الجيزة

٢٤٧١٢٠٩٢١٠٠٠١٢١

١٠٣٣٤٩٩١٣

٢٠٢١/١٢ ٢٤٧١٢٠٩٢١٠٠٠١٢١
 بدون حق

التي مسجلة
 شعبان احمد صالح احمد
 المنطقة سارية حتى ٢٠٢٤/١٢/٢٤

٩



جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عائدة
عبد الله صالح أحمد
بأمر من السيد
الوزير

٢٠٢١
٢٤٧١٢٠٩٢١٠١٢١
JD3349913

-١-١٨٢٤٢٥٢٢

٢٤٤٩
C.C.C. ٤٧٦



٢٠٢١/١١ ٢٤٧١٢٠٩٢١٠١٢١
٢٠٢١/١١



أنتى
شعبان أحمد صالح أحمد
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/١١/١٢



٢٠٢٨/١١/١٢



Patient Name : عبده خلف الله صالح
Patient No : 24712092100121
Sex : Female Age : 76 Y
Financial Cate : أورام دار السلام - مبداء
Department : Out Patient
Referring Doc :

Lab No. : 13009739
Request Date : 12-09-2024 09:31
Verification Date : 12-09-2024 10:28
Sample Type : EDTA Blood
Test Status : Routine
Analyzers : XN350_hermi

Complete Blood Picture

Test	Result	Unit	Ref. Range
Hemoglobin	12.0	g/dL	12.0 - 16.0
RBCs	4.2	$10^6/\mu\text{L}$	4.0 - 6.5
Hematocrit (PCV)	<u>35.4</u>	%	36.0 - 50.0
MCV	84.9	FL	76.0 - 101.0
MCH	28.8	pg	26.0 - 32.0
MCHC	33.9	g/dL	31.5 - 34.5
RDW-CV	<u>14.1</u>	%	11.6 - 14.0
PLT	199	$10^3/\mu\text{L}$	150 - 450
WBCs.Total	8.8	$10^3/\mu\text{L}$	4.0 - 11.5

Differential Leucocytic Count :

	Relative		Absolute		
Neutrophils%	56.2	%	4.95	/cmm	2.00 - 7.00
Lymphocytes%	26.9	%	2.37	/cmm	1.50 - 3.50
Monocytes %	7.8	%	0.69	/cmm	0.20 - 1.00
Eosinophils %	8.6	%	<u>0.76</u>	/cmm	Up to 0.50
Basophils %	0.5	%	0.04	/cmm	Up to 0.10

Signature

Dr.Reaam Abd El Menazem



Patient No. : 24712092100121
Patient Name : الأستاذة / عائده خلف الله صالح
Sex : Female Age: 76 Y
Financial Cate : اورام دار السلام - مباره
Department : Out Patient
Referring Doc :

Request No : 13009739
Request Date : 12-09-2024 09:31
Verification Date : 12-09-2024 10:29
Sample Type : Citrated Plasma
Test Status : Routine
Analyzers : CA600_HERMEL

Coagulation Profile Report

Test	Result	Unit	Ref. Range
PT			
Prothrombin Time	12.3	sec	
Control	11.1	sec	
Activity	85.2	%	
INR	1.11		Therapeutic range 2-4
PTT	30.1	sec	30.0 - 45.0)

Signature

Dr.Reaam Abd El Menaem

اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:



وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "

Follow up / Progress note

Protocol	Day/week Of Protocol	Temperature	WT:	HT:	Blood Pressure	Blood Sugar
			BSA:			

☐ Treatment

☐ Follow-up

Clinical findings:

16/6/2025 :-

O/E: RF 120° ch men

suprakel.

3 x 4

	Doctor Order	الوقت
EF: %	RT and by LN mahl 3 x 5.	
BP:	Chor: HVB.	
TEMP:		
HR:	RI Femara tab 2.5 g 1 x 1 x 30	
HB:	RI Calcium tab 500 1 x 2 x 30	
WBC:	RI one Alphe tab 0.5 1 x 1 x 3	
PLT:	RI Toplexil syrr 1 x 3 x 7	
UREA:	RI orthoglobe Cap 1 x 1 x 30	
CREAT:		
ALT:		
AST:		
T.BIL:		
D.BIL:		

د. د. د. د.
ع. 9/7/17

Doctor Signature: Date: / / 20 Time:

74.
JH
FIN

ملف قيد ٥٠٠/٢

postmen's RR Break:

CT₃, N₂, H₀ CT & BS

IOCTI

En+8/8

pn+8/8

Herz-v

K167 30%

St. Pa f 12/2024 1/2025

CT₃ - Bilat.
pul. Ni
2-3

Se on e
osc hi

BS: 2/2025

for

12/1325 to print is placed for sy

R1 for 1x1x30

M Glen 1x1x30

Plan alph 1x1x30

J

0/12

٥٩٩٥٥٥٥٥
C-00 14/12/2024

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "

Follow up / Progress note

Protocol	Day/week Of Protocol	Temperature	WT:	HT:	Blood Pressure	Blood Sugar
			BSA:			

☐ Treatment

☐ Follow-up

Clinical findings:

Substitute PR

3/1/2025

1. 1.6

_____ (Signature)

Baron Patrick

_____ for Val

	Doctor Order	الوقت
EF: %	AS still pending ChE: Rb breast mass lesion act. larynx LN 2cm فحص ابرأ قرحا يومية لحمه شهريه كالسج قرحه يومية لحمه شهريه ماء الفم قرحه يومية لحمه شهريه باراجول 500 مع قرحه 3 مرات لحمه شهريه لا تسبح لوز سراس	
BP:		
TEMP:		
HR:		
HB:		
WBC:		
PLT:		
UREA:		
CREAT:		
ALT:		
AST:		
T.BIL:		
D.BIL:		

Doctor Signature:

Date: / / 20

Time: _____

F-SMC-ARR-EnvC-PH-0001
Issue No/Review No: 01/00
Issue Date: 1/7/2021

میل تیکسو
گورنر کونسل سرائی
اسٹیشن سیمینار

..... اسم المريض ثلاثي:
..... رقم الملف:



وزارة الصحة و السكان
أمّة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "

PHYSICIAN ASSESSMENT SHEET

I. PERSONAL HISTORY:-

Occupation:
Marital Status : ☐ Married ☐ Single ☐ Widow ☐ Divorced
Special Habits : ☐ Smoking ☐ Coffee ☐ Alcohol ☐ Others
Allergy: ☐ No ☐ Yes - Food: Medications: Others: ☐ Unknown

II. HISTORY:

1.Past History: - ☐ DM ☐ HTN ☐ CLD ☐ IHD ☐ CRD ☐ CVS

☐ Others, specify:

☐ Previous Operations, specify:

☐ Previous Admission to Hospital, ☐ No ☐ Yes Comment

2.Family History:

.....
.....
.....

- Menstrual history : Age at Menarche : 12 Y Ferquency : / Days .
- Regular : No / Yes - Duration : 5-7 Days Pain: No / Yes Discharge: No /
- Menopause: No / Yes - Duration : 1 Y
- History of location:
- History of Miscarriage still birth : No / Yes (Times)
- Children: No. : Sex: Age:

3.Psychological History (Including Emotional/ Behavior/ Social Factors)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4.Current Medication:

Drug	Strength	Dosage/ Frequency	ROUTE

5.Date of First Diagnosis of Cancer
/ / 20

6.Date of First Presentation in Our Unit
/ / 20

7.Present History:

A. The Condition Started by:

.....
.....
.....

Oncology Follow up Sheet

صحيفة متابعة مريض اورام (□ اطفال / □ كبار)

2/8

اسم المريض : عائده خلف الله صالح

الرقم الطبي: رقم الملف: ٤٦٦٩ / ٩٥٦

المعاملة المالية : الرقم القومي : ١٠٩٨٧٦٥٤٣٢١٠

الطبيب المعالج :

العنوان الدائم : الكلية

رقم التليفون: ٤٥٨١٨٤ - ١٠٠ الجنسية: ٤٥٨١٨٤

النوع:
المن:

تاريخ الميلاد: تاريخ أول زيارة: ٨ / ١٠ / ٢٠٢٤

.....: كود الأشعة: